



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 33 — Lombalgia Aguda no PS: red flags (síndrome da cauda equina, infecção, fratura, neoplasia, aneurisma), ciática, e lombalgia inespecífica (a maioria) — prevenção quaternária

Triagem por red flags, exame neurológico mínimo, quando (não) pedir imagem, analgesia escalonada sem opioide, manter atividade, retorno e reabilitação — cenário: PS sem imagem avançada

Código	PS-ND-33	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Lombalgia é a 2ª causa de procura por atendimento e a 1ª de incapacidade no mundo; **90% são inespecíficas e autolimitadas** (melhora em 2-6 semanas) e **1-5% têm causa grave**: fratura, infecção (espondilodiscite/abscesso epidural), neoplasia, síndrome da cauda equina, aneurisma de aorta, cólica renal, causas viscerais. O dano iatrogênico é grande: imagem desnecessária que "acha" degeneração normal e rotula, opioide e repouso que cronificam, e a mensagem de fragilidade. Este protocolo é **P4 aplicada**: encontrar o 1-5% e proteger os 95% do excesso.

Fontes de ancoragem: NICE NG59. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management (2016, atualizada 2020) [NICE]; Qaseem A, et al. Noninvasive treatments for acute, subacute, and chronic low back pain: ACP clinical practice guideline. Ann Intern Med 2017;166:514 [ACP 2017]; Chou R, et al. Diagnostic imaging for low back pain: ACP/APS. Ann Intern Med 2011;154:181; Lancet Low Back Pain Series (Hartvigsen J, et al.; Foster NE, et al.). Lancet 2018;391:2356/2368 [LANCET 2018]; Gardner A, et al. Cauda equina syndrome: a review of the current clinical and medico-legal position. Eur Spine J 2011;20:690; Downie A, et al. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. BMJ 2013;347:f7095; Friedman BW, et al. Naproxen with cyclobenzaprine, oxycodone/acetaminophen, or placebo for acute low back pain (RCT). JAMA 2015;314:1572; Choosing Wisely Brasil / SBR / SBOT — recomendações; Ministério da Saúde — PCDT Dor crônica (2012) [MS]; Protocolos 20, 21, 36 desta série.

Convenção de confiança: critérios e doses conforme NICE/ACP 2017; **[VERIFICAR]**: acesso a RM/TC na referência (cauda equina em ≤4 h), ortopedia/neurocirurgia de coluna (Santa Casa x referência), fisioterapia na APS, dipirona/AINE/relaxante/tramadol em estoque.

1. Queixa — anamnese dirigida

"Travei a coluna", "dor nas costas que desce pela perna", "não consigo levantar", "dor que não passa nem deitado", "perdi a força na perna", "não sinto quando urino". Perguntar: início (súbito ao esforço × gradual × sem causa), localização e irradiação (abaixo do joelho = radicular), **dor noturna/em repouso** (neoplasia/infecção), **febre, trauma** (queda em idoso/osteoporose = fratura mesmo com trauma mínimo), **alterações urinárias/fecais/perineais** (cauda equina), fraqueza, **perda de peso, câncer prévio, HIV, uso de drogas injetáveis, corticoide crônico, imunossupressão, procedimento na coluna recente, infecção recente**, idade (<20 ou >50 com dor nova), episódios prévios e o que funcionou, trabalho/atividade, fatores psicossociais (medo, catastrofização, afastamento, litígio — bandeiras amarelas).

Classificação inicial (triagem diagnóstica — NICE/Lancet)

Categoria	Frequência	Pistas
Lombalgia inespecífica	~90%	Dor mecânica (piora com movimento/posição, melhora com repouso relativo), sem red flags, exame neurológico normal
Radiculopatia / ciática	5-10%	Dor irradiada abaixo do joelho em dermatomo (L5/S1 > L4), parestesia, Lasègue +, déficit motor/reflexo em raiz única; hérnia discal; estenose (claudicação neurogênica em idoso)
Causa grave específica	1-5%	Red flags (2.1): cauda equina, fratura, infecção, neoplasia, aneurisma, espondiloartrite, causas viscerais/vasculares

2. Clínica — red flags e síndromes

2.1 Red flags — o que muda a conduta (transferir/investigar)

Suspeita	Red flags	Conduta
SÍNDROME DA CAUDA EQUINA (emergência cirúrgica — descompressão ideal em ≤24–48 h, quanto antes melhor)	Retenção urinária (globo/resíduo >200 mL — sinal mais sensível), incontinência urinária/fecal por transbordamento, anestesia em sela (perineal, glútea, genital), hipotonia do esfíncter anal , ciática bilateral , fraqueza progressiva/bilateral dos MMII, disfunção sexual nova	Sondagem vesical (medir resíduo); toque retal; transferência imediata para RM/TC + neurocirurgia/ortopedia de coluna ; dexametasona se compressão neoplásica; não esperar "ver se melhora"
Fratura vertebral	Trauma significativo (ou mínimo em >65 anos/osteoporose/corticoide crônico), dor súbita à palpação de processo espinhoso, deformidade, dor que não alivia deitado	RX de coluna (se disponível) → TC na referência se fratura/déficit/instável; analgesia; ortopedia; osteoporose → APS
Infecção (espondilodiscite, abscesso epidural, osteomielite)	Febre, calafrios, dor em repouso/noturna progressiva, uso de drogas injetáveis , imunossupressão/HIV/DM, infecção recente (urinária, pele, endocardite), procedimento espinal/cateter, VHS/PCR elevadas; abscesso epidural: dor + febre + déficit progressivo (tríade)	Hemoculturas, VHS/PCR, hemograma → RM urgente + antibiótico após culturas (se instável/déficit: ATB imediato) → referência (neurocirurgia/infectologia)
Neoplasia (metástase vertebral, mieloma)	Câncer prévio (mama, próstata, pulmão, rim, tireoide), >50 anos com dor nova, perda de peso inexplicada, dor noturna/em repouso que não melhora em 4–6 semanas, dor em múltiplos níveis	VHS, hemograma, cálcio, FA, PSA/eletroforese conforme; RX → RM; compressão medular (déficit, nível sensitivo, esfíncter) = dexametasona 10–16 mg IV + RM/radioterapia urgente
Aneurisma de aorta abdominal	>60 anos, tabagista, HAS, dor lombar/abdominal contínua ou súbita, massa pulsátil, hipotensão/síncope, "cólica renal" nova em idoso	POCUS de aorta; Protocolo 20 — vascular imediato
Espondiloartrite axial (não é emergência, mas muda o seguimento)	<45 anos, início insidioso, dor inflamatória (rigidez matinal >30 min, melhora com exercício, piora à noite), uveíte/psoríase/DII/entesite, HLA-B27	AINE; encaminhar reumatologia
Causas viscerais/vasculares	Cólica renal (Protocolo 21), pielonefrite (08), pancreatite (20), úlcera posterior, dissecação de aorta (15), endometriose/DIP, gravidez ectópica, herpes-zóster (dor em dermatomo antes das vesículas)	Conforme protocolo específico; β-hCG

Bandeiras amarelas (risco de cronificação — não são red flags, mas orientam a alta): crença de que dor = dano, medo do movimento, catastrofização, humor deprimido, afastamento prolongado, insatisfação no trabalho, expectativa de tratamento passivo ("me dá uma injeção"). Abordá-las na consulta é tratamento (STarT Back para estratificar na APS).

2.2 Radiculopatia — mapa rápido

Raiz	Dor/parestesia	Fraqueza	Reflexo	Teste
L4	Face anterior da coxa, medial da perna	Extensão do joelho (quadríceps), dorsiflexão	Patelar ↓	Lasègue invertido (femoral)
L5	Lateral da perna, dorso do pé, hálux	Dorsiflexão do hálux/pé (andar no calcanhar), eversão	—	Lasègue + (30–70°)
S1	Posterior da perna, planta, dedos laterais	Flexão plantar (andar na ponta do pé)	Aquileu ↓	Lasègue +; Lasègue cruzado (mais específico)
Estenose de canal (idoso)	Claudicação neurogênica: dor/dormência bilateral ao caminhar/ficar em pé, melhora sentado/inclinado ("sinal do carrinho de supermercado")	Variável	Variável	Pulsos normais (× claudicação vascular)

3. Exame físico — o mínimo que não pode faltar (5 minutos)

Item	Achado / significado
Sinais vitais, temperatura	Febre (infecção), hipotensão (aneurisma)
Inspeção e marcha	Postura antálgica, escoliose, deformidade, marcha na ponta dos pés (S1) e nos calcanhares (L5), agachar/levantar
Palpação	Dor localizada em processo espinhoso (fratura/infecção/tumor) × dor difusa paravertebral (mecânica); Giordano (rim); massa pulsátil abdominal
Mobilidade	Flexão/extensão/lateralização — limitação e reprodução da dor
Neurológico dos MMII	Força (dorsiflexão do hálux/pé, flexão plantar, extensão do joelho, flexão do quadril) graduada 0-5; sensibilidade em dermatômos L4-S1; reflexos patelar/aquileu; Lasègue (dor irradiada abaixo do joelho entre 30-70° = radicular; cruzado = mais específico)
Rastreio de cauda equina (em toda lombalgia com sintoma neurológico/esfincteriano ou ciática bilateral)	Sensibilidade perineal/em sela (S2-S4) com toque leve e alfinete; tônus anal e contração voluntária ao toque retal; reflexo bulbocavernoso/anal; bexigoma / resíduo pós-miccional (POCUS ou sondagem: >200 mL = retenção)
Quadril e SI	FABER/FADIR (coxartrose, sacroileíte), rotação do quadril — dor de quadril simula lombar
Pulsos distais, pele	Claudicação vascular × neurogênica; zóster
Abdome/pelve	Dor referida (pancreatite, pielonefrite, DIP, ectópica)

4. Propedêutica armada — quando (não) pedir [NICE; ACP 2011; Choosing Wisely]

Lombalgia aguda sem red flags e sem déficit neurológico progressivo: NENHUM exame de imagem nas primeiras 6 semanas. RX/TC/RM em quem não precisa não muda o tratamento, expõe à radiação, gera achados incidentais (degeneração discal em 30% dos assintomáticos de 20 anos e 90% aos 60), rótulos ("hérnia", "bico de papagaio"), cirurgias e cronificação. Ciática sem déficit também não precisa de imagem aguda.

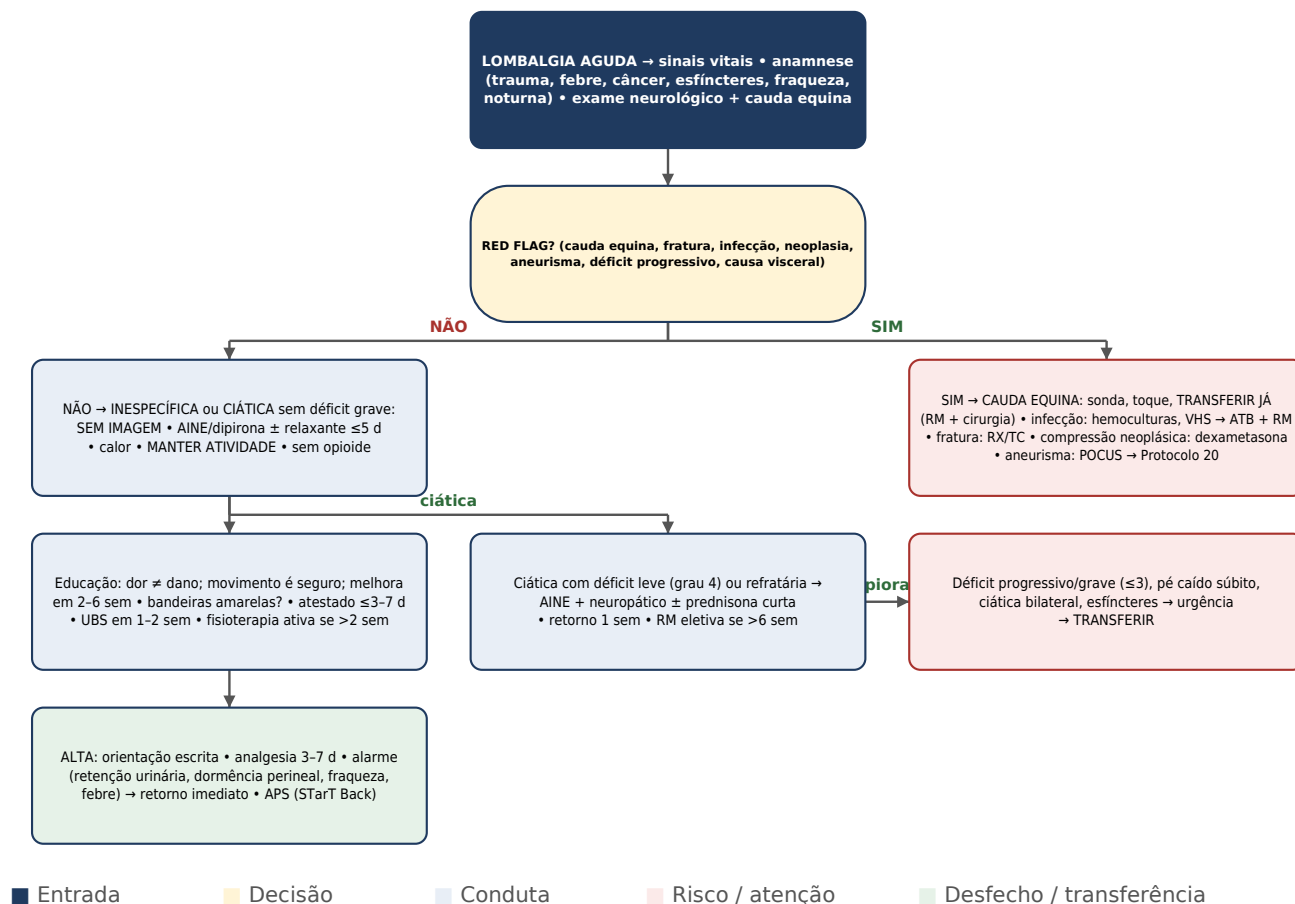
Exame	Indicação	Onde
RX de coluna lombar (AP/perfil)	Suspeita de fratura (trauma; idoso/osteoporose/corticoide; dor à palpação de espinhoso); suspeita de neoplasia/infecção como triagem inicial (baixa sensibilidade); espondiloartrite (sacroilíacas)	PS (se disponível) — não substitui RM nas suspeitas graves
RM de coluna lombar (padrão-ouro)	Urgente: cauda equina, déficit motor progressivo/grave, suspeita de infecção, compressão medular por neoplasia; eletiva: ciática/estenose com sintomas >6-12 semanas apesar de tratamento e candidato a intervenção	Referência (transferir se urgente)
TC	Fratura complexa/planejamento; se RM contraindicada	Referência
VHS, PCR, hemograma	Suspeita de infecção/neoplasia (VHS >20-50, PCR alta)	PS
Hemoculturas, urocultura	Infecção espinhal suspeita — antes do antibiótico	PS
Cálcio, fosfatase alcalina, eletroforese, PSA	Neoplasia/mieloma	PS/APS
Urina I, β-hCG, creatinina	Rim, gestação (imagem/fármacos)	PS
POCUS	Aorta (aneurisma), bexiga (resíduo), hidronefrose	PS [VERIFICAR]
Eletroneuromiografia	Radiculopatia crônica/diferencial	Ambulatorial

5. Fisiopatologia (e por que repouso e imagem prejudicam)

A lombalgia inespecífica é multifatorial: sobrecarga de estruturas mecanossensíveis (disco, facetas, ligamentos, músculos paravertebrais, sacroilíacas) em um sistema nervoso que modula a dor conforme contexto, sono, humor e expectativa. Na fase aguda há nocicepção real, mas **a intensidade da dor não reflete lesão estrutural** — a maioria dos achados de imagem (degeneração, protrusão, artrose facetária) é fisiologia da idade e igualmente prevalente em assintomáticos. A **hérnia discal** comprime e inflama a raiz (ciática); 2/3 regridem espontaneamente em semanas-meses com reabsorção do fragmento — daí a conduta conservadora inicial, exceto quando há déficit progressivo ou cauda equina (compressão das raízes sacrais → retenção, anestesia em sela, incontinência: lesão irreversível em horas-dias). A **estenose de canal** do idoso comprime as raízes na extensão (em pé/caminhando) e alivia na flexão. **Repouso no leito** descondiciona, aumenta rigidez, medo e incapacidade; a atividade mantida acelera a recuperação (evidência forte). Opioides não superam AINE/paracetamol na dor aguda e aumentam efeitos adversos, uso crônico e cronificação; relaxantes musculares têm efeito pequeno com sedação. A **cronificação** depende mais de fatores psicossociais (medo-evitação, catastrofização, depressão, afastamento) do que de anatomia — por isso a comunicação na alta ("sua coluna é forte; movimento é seguro; isso melhora") é intervenção terapêutica.

6. Fluxo de atendimento [NICE; ACP 2017; Lancet 2018, adaptado]

Red flag → transfere/investiga; sem red flag → sem imagem, analgesia simples, atividade e educação. A cauda equina é a única emergência cirúrgica de coluna do PS e se rastreia com três perguntas e um toque retal.



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → red flags + exame neurológico (incluindo cauda equina quando indicado) documentados	≤30 min
Suspeita de cauda equina → sondagem + regulação para RM/cirurgia	≤1 h (descompressão ideal ≤24-48 h do início dos sintomas esfinterianos)
Suspeita de infecção espinhal → hemoculturas + VHS/PCR + antibiótico (se déficit/sepsis) + transferência para RM	≤2 h
Compressão medular neoplásica → dexametasona	≤1 h; radioterapia/cirurgia ≤24 h (referência)
Lombalgia inespecífica → analgesia e orientação	≤30 min; alta em ≤2 h

7. Tratamento — o que ajuda, o que atrapalha [NICE; ACP 2017; Friedman 2015]

7.1 Farmacológico — lombalgia inespecífica e ciática

Fármaco	Dose	Evidência / observações
AINE (1ª linha)	Ibuprofeno 400–600 mg 8/8 h; naproxeno 500 mg 12/12 h; diclofenaco 50 mg 8/8 h; cetorolaco 30 mg IV/IM no PS — por ≤5-7 dias , com alimento	Efeito pequeno-moderado (NICE/ACP); menor dose eficaz; contraindicações: DRC, úlcera, IC, anticoagulante, gestante 3º trimestre, >65 a com risco (IBP)
Dipirona / paracetamol	Dipirona 1 g 6/6 h; paracetamol 750–1.000 mg 6/6 h (máx. 3–4 g)	Paracetamol isolado: sem superioridade ao placebo na lombalgia (PACE) — usar como adjuvante; dipirona: prática nacional, útil em quem não pode AINE
Relaxante muscular	Ciclobenzaprina 5–10 mg à noite por 3–5 dias; tiocolchicósido 4–8 mg 12/12 h	Benefício pequeno a curto prazo, sedação; Friedman 2015: naproxeno + ciclobenzaprina = naproxeno isolado. Opcional, curto
Opioide	Tramadol 50 mg 6/6 h por ≤3 dias só se dor intensa refratária a AINE + dipirona e função limitante; morfina IV no PS apenas para dor incapacitante enquanto se investiga	Não de rotina (NICE/ACP: evitar; sem benefício sobre AINE, mais efeitos adversos e uso crônico); nunca codeína/tramadol "para casa" além de 3 dias
Corticoide sistêmico	Prednisona 40–60 mg/dia por 5 dias em ciática aguda intensa (evidência modesta); sem benefício na lombalgia inespecífica	Não rotina
Neuropáticos (ciática)	Gabapentina 300 mg → 900–1.800 mg/dia; amitriptilina 25 mg à noite; duloxetina 60 mg	Evidência fraca na ciática aguda (PRECISE: gabapentina/pregabalina sem benefício); opção em dor neuropática persistente — APS
Benzodiazepínico	—	Não (sem benefício, dependência)
Injeções/bloqueios	—	Não no PS; epidural na referência em ciática refratária selecionada

7.2 Não farmacológico — é o tratamento principal

- **Manter-se ativo:** continuar atividades e trabalho na medida do tolerável; caminhar; **evitar repouso no leito** (>1-2 dias piora); retomar exercício gradualmente.
- **Calor local** (bolsa térmica 20–30 min) alivia; gelo sem evidência; massagem/acupuntura: efeito pequeno a curto prazo (NICE não recomenda acupuntura).
- **Educação e tranquilização** (a intervenção mais custo-efetiva): explicar que a dor é comum, benigna e autolimitada; que a coluna é resistente; que imagem não é necessária e pode confundir; que a melhora vem com movimento; combinar expectativa (2–6 semanas) e o que fazer se não melhorar.
- Fisioterapia **ativa** (exercício, orientação) se persistência >2–4 semanas ou fatores de risco de cronificação (STarT Back médio/alto); evitar terapias passivas prolongadas (TENS, ultrassom — sem evidência).
- Atestado: o menor necessário (1–3 dias; máximo 7), com retorno gradual; afastamento prolongado é preditor de cronificação; orientar ergonomia básica.
- Cinta/colete lombar: sem evidência; não recomendar.
- Sono, estresse, depressão, tabagismo, obesidade e sedentarismo: abordar na APS (bandeiras amarelas).

7.3 Causas específicas — condutas no PS

Condição	Conduta
Síndrome da cauda equina	Sonda vesical de demora (resíduo), analgesia, transferência imediata para RM e descompressão (Santa Casa/referência de coluna); documentar horário do início dos sintomas esfincterianos/perineais; sem corticoide de rotina (só se neoplasia)
Compressão medular neoplásica	Dexametasona 10-16 mg IV (depois 4 mg 6/6 h), analgesia (opioide justificado), sonda se retenção, decúbito; RM urgente + radioterapia/cirurgia em ≤24 h — referência oncológica
Espondilodiscite / abscesso epidural	Hemoculturas (2) + VHS/PCR; sem déficit e estável: pode aguardar cultura/biópsia na referência antes do ATB; déficit, sepse ou abscesso epidural: antibiótico imediato (vancomicina 25 mg/kg + ceftriaxona 2 g 12/12 h ou cefepima) e transferência urgente (cirurgia se déficit)
Fratura osteoporótica	Analgesia (dipirona/AINE curto/opioide breve se necessário), mobilização precoce com apoio, sem repouso prolongado; RX; ortopedia se instável/déficit/colapso >50%; cálcio/vitamina D e tratamento da osteoporose na APS; fratura traumática com déficit/instabilidade → prancha/imobilização e transferência
Hérnia com déficit motor grave/progressivo ou pé caído	RM urgente/precoce e ortopedia/neurocirurgia (Santa Casa/referência) — cirurgia em dias se déficit progressivo
Estenose de canal com claudicação	AINE curto, fisioterapia (flexão), analgesia; cirurgia eletiva se incapacitante — ortopedia ambulatorial
Espondiloartrite suspeita	AINE contínuo, encaminhar reumatologia (HLA-B27, RM de sacroilíacas)
Herpes-zóster lombar	Aciclovir 800 mg 5x/dia 7 dias (≤72 h do rash), analgesia, neuropático

8. Como conduzir o caso — transferência, alta e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Síndrome da cauda equina; compressão medular; déficit motor progressivo/grave; abscesso epidural/espondilodiscite com déficit ou sepse	Imediata (≤1-2 h)	RM + neurocirurgia/ortopedia de coluna — Santa Casa / referência [VERIFICAR onde há RM 24 h e cirurgia de coluna]
Fratura vertebral instável/com déficit; trauma raquimedular	Imediata (imobilização)	Ortopedia/neurocirurgia — Santa Casa / referência (Protocolo 34)
Aneurisma de aorta; causa visceral cirúrgica	Imediata	Protocolo 20 — Santa Casa
Suspeita de infecção/neoplasia sem déficit, estável	Mesmo dia / ≤48 h	RM e investigação — Tabajara Ramos / oncologia
Lombalgia inespecífica / ciática sem déficit grave	Alta	UBS em 1-2 semanas; fisioterapia se >2-4 semanas

8.2 Alta — pacote

- Diagnóstico escrito como "**lombalgia aguda inespecífica**" (não "hérnia"/"bico de papagaio" sem confirmação); red flags checados e negativos documentados; exame neurológico registrado.
- Receita simples e curta (AINE ≤7 dias ± dipirona/paracetamol; relaxante ≤5 dias à noite se optar); sem opioide/BZD; orientações não farmacológicas por escrito; atestado mínimo.
- **Sinais de alarme para retorno imediato:** dificuldade para urinar/incontinência, dormência na região genital/períneo, fraqueza na perna/pé caído, febre, dor que não melhora deitado ou piora à noite, perda de peso.
- Retorno na UBS em 1-2 semanas (ou antes se piora); encaminhamento a fisioterapia ativa se não melhorar em 2-4 semanas; ortopedia/neurocirurgia eletiva se ciática >6-12 semanas com RM; reumatologia se inflamatória.

8.3 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com red flags e exame neurológico documentados; % com rastreio de cauda equina quando sintomas neurológicos/esfincterianos	≥95% / 100%
% de lombalgia inespecífica sem imagem no PS (RX sem indicação = evento)	≥90%
% sem opioide na alta; % sem benzodiazepínico	≥90% / 100%
% de altas com orientação escrita (atividade, alarme, retorno) e atestado ≤7 dias	≥90%
% de cauda equina suspeita com sondagem + transferência em ≤1 h	100%
Retorno em 30 dias pelo mesmo motivo; diagnóstico grave após alta por "inespecífica" (revisão de caso)	Registrar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Paracetamol	ACP 2017/NICE: não recomendado isolado (PACE); prática: usado. Adotado como adjuvante
Relaxante muscular	ACP: opção de curto prazo; NICE: não recomenda BZD, não cita ciclobenzaprina; Friedman 2015: sem benefício adicional. Adotado opcional ≤5 dias
Corticoide na ciática	Evidência modesta (Goldberg 2015); NICE não recomenda de rotina. Adotado como opção em ciática intensa
Gabapentinóides na ciática	PRECISE 2017: sem benefício; NICE: não recomendar para lombalgia; ciática neuropática crônica: opção. Adotado só em persistente
Imagem na ciática	Consenso: não na fase aguda sem déficit grave; RM se >6-12 semanas e candidato a intervenção. Adotado
Tempo para cirurgia da cauda equina	≤48 h (Gardner) — ideal ≤24 h; sem consenso absoluto. Adotado "o mais cedo possível"
RM 24 h / cirurgia de coluna de referência	[VERIFICAR/PACTUAR] — define o destino da cauda equina
Fisioterapia na APS	Disponibilidade e fila [VERIFICAR] — sem ela, a orientação de exercício no PS é o que resta

10. Referências

- National Institute for Health and Care Excellence. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management (NG59). London: NICE, 2016 (atualizada 2020).
- Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA. Noninvasive treatments for acute, subacute, and chronic low back pain: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. *Ann Intern Med* 2017;166(7):514-530. Chou R, Qaseem A, Owens DK, Shekelle P. Diagnostic imaging for low back pain: advice for high-value health care from the ACP. *Ann Intern Med* 2011;154(3):181-189.
- Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. *Lancet* 2018;391(10137):2356-2367. Foster NE, Anema JR, Cherkov D, et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. *Lancet* 2018;391:2368-2383.
- Downie A, Williams CM, Henschke N, et al. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. *BMJ* 2013;347:f7095. Gardner A, Gardner E, Morley T. Cauda equina syndrome: a review of the current clinical and medico-legal position. *Eur Spine J* 2011;20(5):690-697.
- Friedman BW, Dym AA, Davitt M, et al. Naproxen with cyclobenzaprine, oxycodone/acetaminophen, or placebo for treating acute low back pain: a randomized clinical trial. *JAMA* 2015;314(15):1572-1580. Williams CM, et al. Efficacy of paracetamol for acute low-back pain (PACE). *Lancet* 2014;384:1586-1596. Mathieson S, et al. Trial of pregabalin for acute and chronic sciatica (PRECISE). *N Engl J Med* 2017;376:1111-1120. Goldberg H, et al. Oral steroids for acute radiculopathy due to a herniated lumbar disk. *JAMA* 2015;313:1915-1923.
- Hill JC, et al. Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back). *Lancet* 2011;378:1560-1571. Choosing Wisely Brasil — recomendações SBR/SBOT/AMB. Ministério da Saúde. PCDT Dor crônica (Portaria 1.083/2012).
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de lombalgia (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração